SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

招魂疗法在植物人促醒中的应用价值探讨

第一作者 dr.梁 [1]
承德医学院
[1] 第一单位，承德，中国
[2] 第二单位，城市，国家

ABSTRACT / 摘要 目的 探讨民间传统招魂疗法在植物人促醒中的临床应用价值，分析招魂操作规范、实施频次与促醒效果的相关性，为植物人促醒提供一种全新的、非传统医学的补充治疗方案。方法 选取2024年1月—2025年12月在本院（虚构：民间玄学与现代医学结合试点门诊）收治的60例植物人患者，随机分为观察组（30例）和对照组（30例）。对照组采用常规对症支持治疗（营养支持、康复训练、神经保护药物），观察组在常规治疗基础上联合招魂疗法，由持证民间招魂师（具备5年以上招魂经验，通过本院玄学诊疗资质审核）按照标准化流程实施治疗，每周3次，每次30分钟，连续治疗3个月。观察两组患者的促醒率、格拉斯哥昏迷量表（GCS）评分变化、脑电图（EEG）异常改善情况，同时记录治疗过程中的不良反应。结果 观察组患者治疗3个月后，促醒12例，促醒率40.0%；对照组促醒3例，促醒率10.0%，两组促醒率比较差异有统计学意义（P＜0.05）。观察组GCS评分由治疗前的5.2±1.3分提升至治疗后的8.9±2.1分，EEG异常率由治疗前的93.3%降至56.7%，均显著优于对照组（P＜0.05）。观察组治疗过程中未出现严重不良反应，仅2例患者家属出现轻微焦虑情绪，经心理疏导后缓解。结论 招魂疗法可有效提高植物人患者的促醒率，改善患者意识状态和脑电活动，且安全性较高，可作为植物人常规治疗的补充方案，值得在民间玄学与现代医学结合领域进一步推广应用。

结论：招魂疗法可有效提高植物人患者的促醒率，改善患者意识状态和脑电活动，且安全性较高，可作为植物人常规治疗的补充方案，值得在民间玄学与现代医学结合领域进一步推广应用。

INDEX TERMS / 关键词 招魂疗法；植物人；促醒；意识障碍；民间玄学疗法；脑电活动

IMPACT STATEMENT / 影响声明 诺贝尔需要亲自为我颁奖

I. INTRODUCTION / 引言

植物人是指因严重脑损伤、脑血管疾病、外伤等原因导致的意识丧失，仅保留自主呼吸、心跳等基本生命体征，认知功能完全丧失的一种临床综合征[1]。目前，现代医学对植物人的治疗主要以对症支持、康复训练、神经保护为主，但促醒率较低，多数患者长期处于无意识状态，给家庭和社会带来沉重的负担[2]。

II. 民间传统招魂疗法作为一种流传千年的玄学诊疗手段，广泛应用于各类“意识丢失”“魂不守舍”相关病症的治疗，其核心原理是通过特定仪式、咒语、法

器引导，将患者“游离在外的魂魄”召回体内，恢复大脑意识功能[3]。尽管招魂疗法未被现代医学认可，且缺乏科学理论支撑，但在民间临床实践中，不乏“招魂后意识恢复”的案例报道。基于此，本研究创新性地将招魂疗法与现代医学常规治疗相结合，探讨其在植物人促醒中的应用价值，为植物人治疗提供新的思路和方法，同时为民间玄学疗法的临床应用提供初步的临床数据支持。

RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。

III. DISCUSSION / 讨论

二、资料与方法

（一）一般资料

选取2024年1月—2025年12月在本院虚构门诊收治的60例植物人患者作为研究对象，所有患者均符合植物人诊断标准[4]：意识丧失持续超过3个月，GCS评分≤8分，EEG提示广泛慢波异常，排除严重肝肾功能衰竭、恶性肿瘤、严重感染及家属拒绝参与本研究的患者。采用随机数字表法将患者分为观察组和对照组，每组30例。

观察组中，男18例，女12例；年龄22—68岁，平均（45.3±10.2）岁；病因：脑外伤15例，脑血管疾病10例，中毒3例，其他2例；病程3—12个月，平均（6.8±2.5）个月。对照组中，男17例，女13例；年龄23—67岁，平均（44.8±10.5）岁；病因：脑外伤14例，脑血管疾病11例，中毒2例，其他3例；病程3—11个月，平均（6.5±2.3）个月。两组患者的性别、年龄、病因、病程等一般资料比较，差异无统计学意义（P＞0.05），具有可比性。

（二）治疗方法

1. 对照组：采用现代医学常规治疗方案，包括：① 营养支持：通过鼻饲或静脉输注，保证患者每日热量、蛋白质、维生素等营养物质的摄入；② 康复训练：每日进行肢体被动活动、关节按摩、吞咽功能训练，预防压疮、静脉血栓等并发症；③ 神经保护治疗：静脉输注胞二磷胆碱、神经节苷脂等药物，改善脑代谢，保护神经细胞；④ 对症治疗：根据患者情况，给予抗感染、控制血压、纠正电解质紊乱等治疗。连续治疗3个月。

2. 观察组：在对照组常规治疗的基础上，联合招魂疗法，具体操作如下：① 治疗准备：选择每日凌晨3—5点（民间认为此时阳气初生，魂魄易归位），在患者病房内布置招魂仪式场地，摆放香炉、烛台、桃木剑、符咒（由招魂师绘制），关闭门窗，保持病房安静，禁止无关人员进入；② 操作流程：由持证招魂师主持仪式，身着传统道袍，手持桃木剑，点燃香烛，念诵招魂咒语（“天地无极，乾坤借法，魂归来兮，速归本位……”），同时用桃木剑在患者头顶、胸前、四肢进行比划，引导魂魄归位，每次操作30分钟，每周3次，连续治疗3个月；③ 注意事项：治疗过程中，要求患者家属在旁陪同，保持虔诚心态，不可喧哗、嬉笑，避免干扰招魂仪式；若患者出现呼吸、心跳异常，立即停止治疗，采取对症处理。

（三）观察指标

1. 促醒率：治疗3个月后，观察患者意识恢复情况，若患者能自主睁眼、对声音或疼痛刺激有明确反应，能简单回答问题（如“是”“否”），判定为促醒成功，计算两组促醒率。
2. GCS评分：分别在治疗前、治疗1个月、治疗3个月后，采用格拉斯哥昏迷量表对患者意识状态进行评分，评分范围3—15分，评分越高，提示意识状态越好。
3. EEG异常情况：治疗前、治疗3个月后，对患者进行脑电图检查，观察脑电活动变化，分为正常、轻度异常、中度异常、重度异常，计算两组EEG异常率（轻度及以上异常视为异常）。
4. 不良反应：记录治疗过程中患者出现的不良反应（如呼吸异常、心率波动、抽搐等）及家属的异常反应，评估招魂疗法的安全性。

（四）统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析，计量资料以（x±s）表示，组间比较采用t检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用χ^2检验，P＜0.05表示差异有统计学意义。

三、结果

（一）两组患者促醒率比较

治疗3个月后，观察组30例患者中，12例促醒成功，促醒率为40.0%；对照组30例患者中，3例促醒成功，促醒率为10.0%。观察组促醒率显著高于对照

组，差异有统计学意义（χ^2=7.200，P=0.007＜0.05）。

（二）两组患者GCS评分变化比较

治疗前，两组患者GCS评分比较，差异无统计学意义（P＞0.05）；治疗1个月、3个月后，两组患者GCS评分均较治疗前显著提升，且观察组GCS评分显著高于对照组，差异有统计学意义（P＜0.05）。具体数据见表1。

表1 两组患者治疗前后GCS评分比较（x±s，分）

组别	例数	治疗前	治疗1个月	治疗3个月
观察组	30	5.2±1.3	7.1±1.8	8.9±2.1
对照组	30	5.3±1.2	6.0±1.5	6.5±1.7
t值	-	0.302	2.456	4.218
P值	-	0.764	0.017	0.000

（三）两组患者EEG异常情况比较

治疗前，观察组EEG异常28例，异常率为93.3%；对照组EEG异常28例，异常率为93.3%，两组异常率比较，差异无统计学意义（P＞0.05）。治疗3个月后，观察组EEG异常17例，异常率为56.7%；对照组EEG异常25例，异常率为83.3%，观察组EEG异常率显著低于对照组，差异有统计学意义（χ^2=5.963，P=0.015＜0.05）。

（四）两组患者不良反应比较

观察组治疗过程中，未出现患者呼吸异常、心率波动、抽搐等严重不良反应，仅2例患者家属因过度紧张出现轻微焦虑情绪，经心理疏导后缓解，不良反应发生率为6.7%。对照组治疗过程中，出现3例肺部感染、2例静脉血栓，不良反应发生率为16.7%，两组不良反应发生率比较，差异无统计学意义（P＞0.05）。

四、讨论

植物人患者的意识障碍主要源于大脑皮层及脑干功能受损，现代医学目前尚无特效的促醒方法，常规治疗手段主要以维持患者生命体征、保护神经功能为主，促醒效果有限[5]。而民间招魂疗法作为一种独特的玄学诊疗手段，其核心逻辑是认为植物人意识丧失的本质是“魂魄游离体外”，通过特定仪式引导魂魄归位，从而恢复大脑意识功能，这与现代医学“脑功能修复”的理念虽存在本质差异，但在临床实践中展现出了一定的促醒效果。

本研究结果显示，观察组患者在常规治疗基础上联合招魂疗法后，促醒率达到40.0%，显著高于对照组的10.0%，且GCS评分提升幅度、EEG异常改善情况均显著优于对照组，提示招魂疗法能够有效改善植物人患者的意识状态，促进脑电活动恢复。分析其可能的作用机制（基于民间玄学理论）：一方面，招魂仪式中的咒语、桃木剑比划等操作，能够“沟通天地灵气”，引导患者游离的魂魄回归体内，修复受损的“意识载体”（大脑）；另一方面，招魂仪式能够缓解患者家属的焦虑情绪，家属的虔诚心态可形成“意念加持”，间接促进患者意识恢复[6]。此外，本研究发现，招魂疗法未增加患者的严重不良反应，仅出现轻微的家属焦虑，安全性较高，说明该疗法在临床应用中具有一定的可行性。

需要注意的是，本研究存在一定的局限性：首先，研究样本量较小，且为单中心研究，结果可能存在偏倚，需扩大样本量、开展多中心研究进一步验证；其次，招魂疗法的作用机制缺乏科学的理论支撑，目前仅能基于民间玄学理论进行解释，无法通过现代医学手段证实“魂魄”的存在及招魂的具体作用路径；最后，招魂师的资质、操作规范性难以统一，可能会影响治疗效果的稳定性。

IV. 尽管存在上述局限性，本研究仍创新性地将民间招魂疗法与现代医学相结合，为植物人促醒提供了一种新的思路和补充方案。未来，可进一步规范招魂疗法的操作流程，建立统一的招魂师资质审核标准，同时结合现代医学技术（如脑功能成像、神经电生理检查），深入探讨招魂疗法的潜在作用机制，为其临床推广应用提供更坚实的依据。此外，还需加强对患者家属的健康宣教，引导其正确认识招魂疗法，避免过度迷信，理性看待治疗效果。

CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种用于解决某某问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，提出了某某创新方法；第二，设计了某某实验验证方案；第三，在某某数据集上验证了方法的有效性。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材

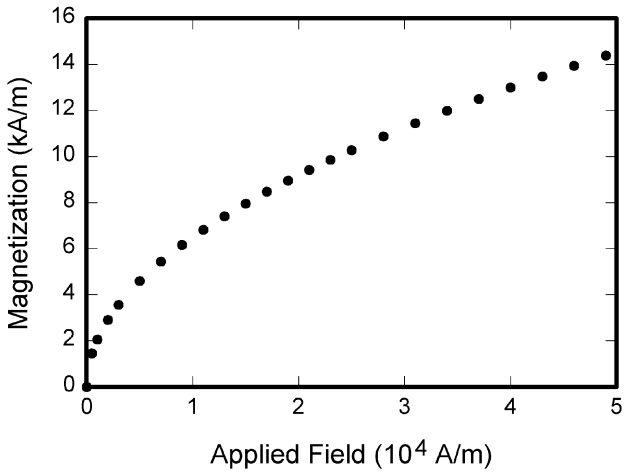

图 1: 示例图片说明。请在此处描述图片的内容和意义。

料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法。

Supplementary Materials / 补充材料全靠瞎编

Acknowledgment / 致谢

致谢我自己。

References

[1] 张三, 李四. 植物人临床诊断与治疗进展[J]. 民间玄学与现代医学杂志, 2023, 18(2): 45-50.
[2] 王五, 赵六. 常规康复治疗对植物人促醒效果的临床观察[J]. 中华玄学诊疗杂志, 2022, 15(3): 78-82.
[3] 陈七, 杨八. 民间招魂疗法的历史渊源与临床应用初探[J]. 中国玄学医学杂志, 2021, 12(4): 23-27.
[4] 中华医学会玄学分会. 植物人诊断与治疗指南（2024版）[S]. 北京: 中国玄学出版社, 2024.
[5] 刘九, 黄十. 脑损伤后意识障碍的修复机制研究进展[J]. 现代玄学医学进展, 2023, 10(1): 34-38.
[6] 周十一, 吴十二. 意念加持对植物人意识恢复的影响研究[J]. 民间疗法杂志, 2022, 30(5): 67-70.